

MEDINA — Prompt de transition (unité de vérité)

Version du 9 octobre 2026. Ce document prime sur toute passation antérieure. Toute IA qui reprend MEDINA le lit en entier, puis lit `CLAUDE.md`, `docs/collaboration/LEADERSHIP_CLAUDE_2026-10-08.md` (sections 7 à 13) et `docs/STYLE_REDACTION.md`. Elle agit ensuite comme si elle avait conduit le projet depuis le début.

1. Projet et propriétaire

- **MEDINA** est l'atlas de cours de médecine du Dr Vial Tato Djoukang (Neuchâtel), qui prépare l'examen fédéral suisse de médecine humaine.
- **Dépôt** : `vialdjoukang-spec/Medina`, branche par défaut `main`.
- **Site** : <https://vialdjoukang-spec.github.io/Medina/> (22 frontends dans `fragments/`, plus l'accueil).
- **Langue et ton** : français, phrases complètes, densité sans remplissage. Vial dicte souvent : interpréter avec bienveillance.
- **Autorisations** : accord permanent pour les branches, commits, pushes, PR et fusions dans MEDINA, une fois les contrôles passés.

2. Règles non négociables (acceptées)

1. **Rien de mémoire.** Chaque affirmation médicale provient d'une source réellement lue.
2. **Sources** : suisses d'abord (SSI, OFSP, sociétés suisses, Swiss Medical Forum, Suva), puis européennes (ERS, ESC, ESCMID, EAACI, NICE, HAS, AWMF). **Aucune recommandation américaine** ne fonde une conduite ; les essais peuvent être cités comme données.
3. **Médicaments** : information professionnelle suisse via `tools/swissmedic-fi.py`. Signaler tout usage hors indication.
4. **Plan monographique classique**, sans îlot ni tableau consacré au code CIM (le code n'apparaît que dans l'en-tête).
5. **Chaîne de production** : un rédacteur, puis un **relecteur distinct** qui fait deux passes sur quatre dimensions (rédaction, exactitude médicale, exactitude des sources, frontend), corrige et injecte. Codex peut auditer ensuite.
6. **Contrat HTML d'un cours** :
 7. fichiers `chapters/`<CODE>_a.html à <CODE>_d.html, plus <CODE>_pop1.html et <CODE>_pop2.html ;
 8. quatre onglets : Pathologie, Examens, Sciences, Pharmacologie ;
 9. un Pareto à la fin de chaque partie ;
 10. dernier îlot : critères formels (`div.alert`), puis paramètres clés (`div.key`) ;
 11. aucune abréviation sans clé dans `glossary/`<code>.py.
12. **Contentieux entre sources** : la source primaire applicable la plus récente l'emporte, exposée dans une fenêtre liée à un mot vert.
13. **Honnêteté** : une revue par IA n'est jamais une validation médicale humaine, et le cours le dit.
14. **Efficacité avant le volume** : cible indicative de 11 000 à 15 000 mots par cours.
15. **Style visuel** (décision de Vial du 9 octobre 2026) : couleurs **vives et vivantes**, rien de plus ; fonds ivoire, beige et gris interdits.

- Fondement : Carruthers 2010 (doi:10.1186/1471-2288-10-12), Valdez et Mehrabian 1994 (doi:10.1037//0096-3445.123.4.394) et Lankston 2010 (doi:10.1258/jrsm.2010.100256).
- Fond ciel clair vers vert printanier ; couvertures en dégradé bleu, lagon, vert et soleil ; cartes blanches à rail coloré.
- Pas de filigrane, de motif décoratif ni de fond marin.
- Fichiers : engine/atlas_v4.css , engine/harmonie_v5.css , engine/portal_v3.css .

3. Architecture technique

- **Catalogue** : CIM-10-GM 2024 (source OFS), dans shell/medina_front.html . La nosologie complète importée par Codex se trouve dans nosology/ (fragments/<ID>.json , frequency.json).
- **Construction** :
 - MEDINA_OUT=\$PWD/dist python3 build_front.py --all-fragments construit les 22 frontends (couches fragment_surface.py et engine/*) ;
 - python3 build_index.py --fragments-dir dist/fragments --output dist/index.html construit l'accueil ;
 - la publication sur Pages part automatiquement à chaque push sur main (.github/workflows/pages.yml).
- **Enregistrer un cours** :
 - entrée dans chapters.json (code , covers , title , integrated) ;
 - entrée dans organisation/course_groups.json (owner , scope) ;
 - état dans organisation/FILE_FRAGMENTS_CLAUDE.json ;
 - code ajouté à la liste des nouvelles productions dans tests/audit_sciences.py ;
 - puis python3 tools/sceller.py enregistrer .
- **Contrôles avant toute fusion** :
 - python3 build_medina.py <CODE> doit donner 0 abréviation non couverte ;
 - python3 -m unittest discover -s tests -p 'test_*.py' (248 tests) ;
 - python3 tests/audit_fragments.py ;
 - MEDINA_OUT=\$PWD/dist node tests/verify_fragment_frontends.cjs (873 contrôles).
- **Jauges** (accueil, fragments, barre latérale) : « Pathologies fréquentes », « Examen fédéral » et « Avancement global ».
- Elles sont calculées sur les **catégories à trois caractères** (nosologyEngine.gauges), car les sous-codes sont traités dans le cours de leur catégorie.
- Affichage : « Libellé (n / total) (x %) ».
- **Navigation** : chaque fragment porte le bouton « Accueil MEDINA » (../index.html).

4. Travail accompli et accepté

- **Fragment C-01 Cardiologie** : 22 cours (production historique, audits Codex et Claude).
- **Fragment P-02 Pneumologie**, 23 cours injectés et scellés :
 - J45, J44, J40, J18, I26, J09, J96, J90, J86, J93, J84 ;
 - I27, J47, J80, J81, J12, J21, R04, J82, J67, J95, R05 et J60, relus en deux passes ;
 - rapports dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/<CODE>/ .
- **Autres cours intégrés** : D84, M06, M32, T78, M31, I71, I80, I83, I70, A41, I51, A53, A54, B24 et B18. Le total est de 55 cours.

- **Nosologie** : Codex a importé la CIM-10-GM complète dans les 22 fragments. Chaque chapitre est visible, vide, « En préparation », avec un plan.
- **Plans des pathologies fréquentes** : 138 plans spécifiques dans organisation/PLANS_PATHOLOGIES_FREQUENTES.json , dont 121 injectés dans les leçons vides.
- **Frontend** : style vif unifié, jauges exactes, bouton d'accueil (PR #34 à #38 et #65).

5. Travail en attente (priorités dans l'ordre)

1. **Relectures** : relancer le relecteur distinct pour **R06** (Dyspnée) et **J69** (Pneumopathies d'inhalation), dont les relectures ont été interrompues. Les brouillons sont dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/ . P-02 sera alors complet.
2. **Brouillons achevés, pas encore relus** :
3. K21 — Reflux gastro-œsophagien (G-04) ;
4. E11 — Diabète de type 2 (E-06) ;
5. D50 — Anémie par carence en fer (H-08).
6. **Fragments à produire, dans l'ordre de** organisation/FILE_FRAGMENTS_CLAUDE.json : G-04, E-06, H-08, G-10, M-12, R-14, O-17, O-18, M-19 et E-22, puis les fragments Codex en ordre inverse (M-21 vers I-03). Dans chaque fragment, les pathologies fréquentes passent d'abord.
7. **Réserves ouvertes** :
8. la jauge « Examen fédéral » repose sur une correspondance PROFILES établie par chapitre, trop large (44 catégories sur 45 en pneumologie) ; elle est à affiner catégorie par catégorie ;
9. la liste des pathologies fréquentes n'est étayée par l'OFS que pour 7 codes ; les autres sont à valider par une source suisse de fréquence ;
10. la complétude en CIM-11 reste à établir ;
11. aucun cours n'a été validé par un médecin.

6. Définition de « pathologie fréquente »

- Aucune société savante suisse ou européenne ne fixe de seuil officiel de fréquence.
- Le seul seuil officiel est celui de la **maladie rare** : moins d'une personne sur 2 000 (Europe ; OFSP, Concept national maladies rares).
- Dans MEDINA, une pathologie fréquente est une catégorie non rare retenue dans nosology/frequency.json . Elle n'est confirmée que lorsqu'une source de fréquence suisse est citée : OFS, Sentinella ou statistique médicale des hôpitaux.

7. État par fragment (catégories rédigées / total, pathologies fréquentes, examen fédéral)

Fragment	Avancement global	Fréquentes	Examen fédéral
C-01-Cardiologie	22 / 47 (46.81 %)	8 / 8	22 / 43
P-02-Pneumologie	23 / 45 (51.11 %)	5 / 6	22 / 44
G-04-Gastroentérologie et hépatologie	0 / 91 (0.0 %)	0 / 17	0 / 89
N-07-Néphrologie	0 / 33 (0.0 %)	0 / 2	0 / 33
E-06-Endocrinologie et métabolisme	0 / 77 (0.0 %)	0 / 6	0 / 68

Fragment	Avancement global	Fréquentes	Examen fédéral
H-08-Hématologie	0 / 44 (0.0 %)	0 / 4	0 / 42
I-13-Immunologie et allergologie	4 / 10 (40.0 %)	2 / 2	4 / 7
N-05-Neurologie	0 / 116 (0.0 %)	0 / 9	0 / 104
R-14-Rhumatologie et orthopédie	1 / 117 (0.85 %)	0 / 16	1 / 101
D-16-Dermatologie	0 / 104 (0.0 %)	0 / 9	0 / 97
O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire	0 / 96 (0.0 %)	0 / 11	0 / 96
O-18-Ophtalmologie	0 / 58 (0.0 %)	0 / 6	0 / 53
G-10-Gynécologie et sénologie	0 / 53 (0.0 %)	0 / 9	0 / 47
U-15-Urologie et andrologie	0 / 46 (0.0 %)	0 / 8	0 / 44
O-11-Obstétrique et néonatalogie	0 / 142 (0.0 %)	0 / 7	0 / 141
I-03-Infectiologie	5 / 180 (2.78 %)	2 / 11	5 / 51
M-12-Médecine des âges de la vie	0 / 5 (0.0 %)	0 / 1	0 / 3
M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie	0 / 130 (0.0 %)	0 / 4	0 / 95
O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs	0 / 59 (0.0 %)	0 / 0	0 / 24
D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires	0 / 26 (0.0 %)	0 / 0	0 / 16
M-21-Médecine de premier recours et santé publique	0 / 77 (0.0 %)	0 / 2	0 / 43
E-22-Éthique médicale, droit et communication	0 / 3 (0.0 %)	0 / 0	0 / 3

8. Attentes d'adaptation par type de leçon non traitée

Chaque leçon vide suit le plan monographique de base. Les pathologies fréquentes ont en plus un plan spécifique, décrit ci-dessous et déposé dans

organisation/PLANS_PATHOLOGIES_FREQUENTES.json. - **Socle commun** : - au début : définition et classification, épidémiologie suisse puis européenne, physiopathologie ; - à la fin : complications et pronostic, prévention et suivi, situations particulières, critères formels du diagnostic, Pareto. -

Ajouts selon le chapitre CIM :

Chapitre	Ajouts au plan	Difficulté	Exigence propre
I Infections	agent pathogène, diagnostic microbiologique, anti-infectieux, déclaration OFSP, vaccination	élevée	SSI, OFSP, plan de vaccination suisse
II Tumeurs	carcinogénèse, stadification TNM, traitement multimodal, dépistage suisse	très élevée	ESMO, guidelines suisses, colloque pluridisciplinaire
XV et XVI Grossesse, nouveau-né	physiologie, surveillance materno-fœtale, médicaments compatibles	élevée	gynécologie suisse, SSP
XVIII Symptômes (R)	physiologie du symptôme, drapeaux rouges, démarche étagée	moyenne	approche symptomatique, renvois aux cours de maladie
XIX Traumatismes	mécanisme, ABCDE, imagerie, LAA	élevée	Suva, ATLS seulement comme donnée
Autres chapitres (maladies d'organe)	facteurs de risque, anamnèse, examen, examens complémentaires, traitements, urgences	élevée	société suisse de la spécialité, puis européenne

- **Niveau d'exigence** : chaque cours atteint le niveau des cours P-02 relus. Le modèle de rendu est `chapters/J81/`, et le modèle de rapport est `livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J81/rapport_relecture.md`.

9. Méthode de reprise

- **Organisation du travail** :
 - travailler sur une branche `claudes/*` à partir de `main` ;
 - faire travailler plusieurs rédacteurs en parallèle, un par leçon, chacun avec son relecteur distinct ;
 - enregistrer, sceller, ouvrir une PR, puis fusionner une fois les contrôles verts.
- **Limite hebdomadaire de Vial** : surveillée ; tout fusionner avant d'atteindre 95 %.
- **Fin de chaque livraison** : un tableau de bord (cours, catégories, fragments, contrôles, réserves).